

肺炎(或泌尿道感染)是老人家身體功能退化的綜合表現, 包括

- 臥床時間變長
- 咳痰力氣變弱
- 氣管纖毛排痰能力退化(或輸尿管平滑肌排尿能力退化)
- 咽喉肌肉吞嚥能力退化, 噎到(食物、水、口水沒有正確地進入食道, 反而進入氣管)變多。有時噎到會以進食後咳嗽表現, 但微小的噎到不一定會咳嗽。即使有些人放置鼻胃管, 也只能減少噎到, 無法完全消除。
- 身體整體免疫力下降

所以即使在家照顧 **100** 分, 包括翻身、拍背、抽痰、使用鼻胃管...也只能降低肺炎(或泌尿道感染)發生的幾率。肺炎(或泌尿道感染)還是可能發生, 這不代表照顧得不夠好, 是因為它其實是身體功能退化的綜合表現。

肺炎(或泌尿道感染)很常反復發生, 也是因為它其實是身體功能退化的綜合表現。常常病人才剛出院不久, 又發燒/有痰/呼吸喘又送到醫院。甚至是在同一次住院狀況有好轉, 甚至是準備出院時, 又再惡化。而且細菌在每次的抗生素治療下, 會累積抗藥性, 每一次的肺炎(或泌尿道感染)都比上次棘手, 最終某一次感染嚴重, 帶走我們親自的家人。

呼吸是每分每秒都在進行的事情。肺炎的惡化常常很快, 肺炎可能在幾個小時到半天內就進展到“呼吸衰竭”——氣一旦不夠, 人就沒了。可能早上我們看他狀況還不錯, 下午就被告知他呼吸衰竭了。肺炎一直是老人家名列前茅的死因之一。

來到急診後, 我們已經使用氧氣、抗生素、點滴、胸腔照護等進行治療。病況的惡化常常很快, 但復原往往需要時間。老人家的肺炎要好轉, 往往需要兩個星期或是更久的時間。